DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

IDENTIFICACIÓN

Paciente: JOSE ALONSO PUERTAS CARDENAS **Identificación** CC 2461714
Edad: 78 AÑOS **Empresa:** NUEVA EPS S.A CONTRIBUTIVO-2025
Sala: QUIROFANO 5 **Fecha programación de cirugía:** 03/11/2026

Sede de Atención: SEDE PRINCIPAL

CIRUGÍAS

CANT	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CIRUGÍA	Grupo Quirúrgico	UVR
1	**471102**	**APENDICECTOMIA VIA ABIERTA**	Y38	

Cirujano: DAVID MARTINEZ **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
Vía:

1	**540013**	**DRENAJE DE COLECCION INTRAPERITONEAL VIA ABIERTA**	Y39	

Cirujano: DAVID MARTINEZ **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
Vía: ABDOMEN

1	**540101**	**LIBERACION DE PLASTRON EN ABDOMEN VIA ABIERTA**	Y39	

Cirujano: DAVID MARTINEZ **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
Vía: ABDOMEN

1	**541701**	**LAVADO PERITONEAL TERAPEUTICO VIA ABIERTA**	Y38	

Cirujano: DAVID MARTINEZ **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
Vía: ABDOMEN

1	**545001**	**LISIS DE ADHERENCIAS PERITONEALES VIA ABIERTA**	Y40	

Cirujano: DAVID MARTINEZ **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
Vía: ABDOMEN

DESCRIPCIÓN CIRUGÍA

CIRUJANO ESP34 DAVID MARTINEZ **Especialidad** CIRUGIA GENERAL

471102 **APENDICECTOMIA VIA ABIERTA**
540013 **DRENAJE DE COLECCION INTRAPERITONEAL VIA ABIERTA**
540101 **LIBERACION DE PLASTRON EN ABDOMEN VIA ABIERTA**
541701 **LAVADO PERITONEAL TERAPEUTICO VIA ABIERTA**
545001 **LISIS DE ADHERENCIAS PERITONEALES VIA ABIERTA**

Dx Preoperatorio: K359 APENDICITIS AGUDA NO ESPECIFICADA

Dx Postoperatorio: K350 APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS GENERALIZADA

Tipo de Herida: CONTAMINADA **Tipo de Anestesia:** RAQUIDEA **Tipo de Cirugía:** URGENCIAS
Cantidad de Sangrado: 0 **ml.** **Vía:** UNICA VIA
Clasificación de riesgo quirúrgico : **A.S.A :** 0 **NNIS :** 0
Realización Acto Quirúrgico: **Fecha Inicio** 03/11/26 **Fecha Final** 03/11/26
Hora Inicio 03:20:00 **Hora Final** 04:07:00
Tiempo de Perfusión: 0 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 0 **Minutos**

Descripcion Quirúrgica:
CONSENTIMIMENTO INFORMADO, PAUSA DE SEGURIDAD.
ANESTSIA RAQUIDEA, ASEPSIA Y ANTISEPSIA, SE COLOCA CAMPOS QUIRURGICOS.
ABORDAJE POR LINEA MEDIA INFRA Y SUPORA UMBILICAL. DISECCION POR PLANOS A CAVIDAD ABDOMINAL, SE ENCUENTRA LO DESCRITO EN HALLAZGOS.
DRENAJE DE COLECCION INTRA ABDOMINAL, MATERAIL PURULENTO, SE TOMA MUESTRA PARA CULTIVO Y ANTIBIOGRAMA.
LIBERACION DE PLASTRON DE EPIPLON SOBRE COLON DERECHO Y ASS DE INSTESTINO DELGADO.
LISIS DE ADHERESIAS DE SEGMENTO DE INTESTINO DELGADO: INTER ASAS , DE INTESTINO DELGADO A EPIPLON Y APENDICE CECAL.
SE IDENTIFICA APENDICE CECAL, DISECCION RETROGRADA: PINZA,LIGA Y CORTA, LIGADURA DEL MUÑON CON SEDA 0.
ELECTROFULGURCION DE MUCOSA DE MUÑON APENDICULAR CON ELECTROCAUTRIO.
PINZ,LIGA Y ORTA MESOA APENDICVE , LIGADURA DEL MUÑON DE MESO APENDICE CON SEDA 0.
LAVADO DE CAVIDAD ABDOMINAL CON 4000 CC DE SOLUCION SALINA A NIVEL D MARCO COLICO DERECHOS E IZQUIERDO, CUPULA DIAFRAGMATICA DERECHA E IZQUIERDA, AGUJERO PELVICO E INTER ASAS, LAVADO EXAUSTIVO HASTA OBTENERE RETORNO LIMPIO .
SANGRADO DE FASCIA DE TOLD DERCHA DISECADA Y PERIYTONEL DE MARCO COLICO POR PROCESO INFLANMATIO AGUDO,

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

LEVE SNGRADO POR CAPAS, PERSISTE A LA HEMOSTSIA CON ELECTROCAUTERIO, MOTIVO POR EL CUAL SE COLOCA MATERIAL HEMOSTATICO SURGICEL FIMBRILAR # 1.
SE COLOCA DREN ABDOMINAL POR CONTRA ABERTURA EN : FOSA ILIACA DERECHA- LINEA AXILAR ANTERIOR (SONDA DE NELATON # 18 FR), SE UBICA EN AGUJERO PELVICO, SE FIJA A PIEL CON PROLENE 0.
CONTEO COMPLETO DE COMPRESAS, DOCUMENTADA POR INSTRUMANTADORA Y AUXILIR DE ENFERMERIA.
FASCIA DE PRED ABDOMINAL DE MALA CALIDAD, RAZON POR LA CULA SE TALLA COLGAJO LOCAL SIMPLE DE 2 CM, PARA IDNTIFICAR FASCIA DE MEJOR CALIDAD Y CONSISTNSIA PARA CIERRE DE PARED ABDOMINAL.
SUTURA DE FSCIA CON POLENE 1, PUNTOS CONTINUOS, CIERRE DE PARED ABDOMINAL.
LAVADO DE HERIDA QUIRUGICA CON ABUNDANTE SOLUCION SALINA, HEMOSTASIA, SE FIJA CICATRIZ UMBILICAL A FASCIA CON VICRIL 1, PUNTOS SUBCUTANEOS CON VICRIL 1, PUNTOS DE PIEL CON PROLENE 3/0-INTRADERMICOS.
SE COLOCN APOSITOS LIMPIOS SOBRE HERIDA QUIRUGICA , SE FIJA A PIEL CON MICROPORE

Complicaciones : **SI** ☐ **NO** ☒

Hallazgos :

COLECCION DE MATERIAL PURULENTA LIBRE EN CAVIDAD APROXIMADAMENETE 2000 CC .
EDEMA Y DILATACON DE ASAS DE INTESTINO DELGADO.
PLASTRON DE SEGMENTO DE EPIPLON MAYOR ADHERIDO SOBRE COLON DERECHO ,CIEGO, ILEO.
MULTIPLES ADHERESIAS DE ASAS DE INTESTINO INTER/ASAS Y ADHEREASIS DE SEGMENTO DE INTESTINO DELGADO EN PLASTRON DE EPIPLON MAYOR.
A 20 CM DE VALVULA ILOCECAL, ADHERESIAS A APENDICE CECAL, PRODUCEN LACERACION DE SEROSA DE APROXIMADAMENETE 10 X 3 CM. SIN PERFORACION
APENDICTIS AGUDA FASE IV, PERFORACION DE APENDICICE CECAL EN SU TRCIO DISTAL Y MEDIO.
FASCIA EL LINEA MEDIA DE HERIDA QUIRURGICA DELGADA,FRIABLE , DE MALA CALIDAD, SE DESFARA CON FACILIDAD A LA TRACCION.
SANGRADO FACIL POR CAPA A NIVEL DE FASCVIA DE TOLD /PERITONEO DE MARCO COLICO DERECHO, POR PROCESO INFLAMATORIO, SANGRADO POR CAPAS , NO CONTROALDO POR ELECTROCAUTERIO.

SE UTILIZA
#1.....SURGICEL FIBRILAR

Tejidos enviados a patología : **SI** ☒ **NO** ☐

APENDICE CECAL

OTROS PARTICIPANTES

CÓDIGO	NOMBRE	TIPO
ES118	ANDRIW CORREA MONTOYA	ANESTESIOLOGO
MG246	JONATHAN VELEZ ANGULO	AYUDANTE

David Martinez S.
CIRUGIA GENERAL
C.C. 7675401

DAVID MARTINEZ
Reg. 502602
CIRUGIA GENERAL

***** FIN DEL REPORTE *****